

原位新膀胱手術

WARWIKI

病人須知 · 用自己嘅腸造一個新膀胱，連接尿道，毋需外袋排尿

原位新膀胱係用你自己一段腸造成嘅新膀胱，連接到尿道，等你可以正常排尿 — 毋需掛袋 — 喺膀胱切除或失去功能之後。要學好排空同控制，需要時間同練習。

關於呢個手術

醫生會取出約 **16–24 吋小腸**，折疊造成低壓儲尿囊，接駁到你嘅**尿道**；輸尿管（由腎臟引尿嘅管）亦會接入新膀胱。**毋需造口，毋需袋。**

因為新膀胱係由腸造成，它**唔會**產生「想去廁所」嘅感覺，所以你要學識：

- 按**時間表**排尿 — 放鬆盆底肌並輕輕用力 — 包括**夜間定時起床**排尿。
- 若排唔清，要用尿管自我導尿（女性較常見）。
- 做**盆底運動（凱格爾運動）**加強控制力。

控制力會在數個月內改善；初期漏尿（尤其夜間）係正常嘅。並非所有人都適合 — 視乎你嘅尿道、腎功能同能否堅持日常護理。

安唔安全？

原位新膀胱係成熟嘅手術方案，效果最接近自然排尿。手術比迴腸膀胱造口複雜，康復期較長，需要更多學習。風險包括：出血、感染、漏尿、日間或夜間失禁、排不清需要導尿、尿液帶黏液、尿道感染（UTI），以及長期需要監察電解質、維他命及腎功能。

詞彙解釋

新膀胱（Neobladder）

用一段腸造成嘅新膀胱。

原位（Orthotopic）

放喺正常位置並接駁尿道，讓你正常排尿。

尿道

尿液離開身體所經過嘅管道。

輸尿管

由腎臟引尿入新膀胱嘅管。

定時排尿

按固定時間表排尿（日夜均需），而唔係等到有尿意先去。

自我導尿

自己插入細管，將新膀胱嘅尿排清。

盆底肌

幫助控制及釋放尿液嘅肌肉群。

黏液

腸分泌嘅滑液；尿液中出現細絲狀黏液係正常嘅。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉下進行，過程中你唔會有感覺。之後肚子會酸痛，腸道需要幾日「醒」過嚟。醒後你會帶住一條尿管（留約 2-3 星期）及軟支架管。大部分人住院約 5-8 日；手術本身時間較長。

點樣準備（手術之前）

- 手術係全身麻醉下進行 — 遵從所有術前指示（禁食、按指示停止薄血藥）。你可能需要做腸道清潔。
- 了解術後要求：日夜定時排尿、可能需要自我導尿，以及盆底運動。
- 戒煙，並安排家人或朋友術後協助照顧。

請提早告知醫療團隊，如果你：

- 正在服用薄血藥，或目前有感染
- 有腸道疾病或腎臟問題，或曾做腹部手術或接受放射治療

手術點樣做

- 1 你係麻醉下入睡，並使用抗生素。
- 2 取出一段腸，剩餘腸道重新接駁。
- 3 取出嘅腸剪開並折疊成儲尿囊，縫接到尿道。
- 4 輸尿管接入儲尿囊；放入尿管及軟支架管等待癒合。

之後

- 約 5-8 日後出院，需帶住尿管約 2-3 星期；可沖洗尿管以清除黏液。
- 拔管前需做癒合 X 光檢查確認新膀胱無滲漏。
- 之後學習定時排尿（夜間定鬧鐘）、盆底運動，以及如有需要時的自我導尿。
- 初期漏尿（尤其夜間）係正常，會隨月份改善。黏液正常；多飲水；需要終身覆診（包括監察維他命 B12）。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或發冷
- 排唔到尿或尿管唔滴尿
- 肚子劇痛、嘔吐，或無排氣或大便
- 大量出血、傷口紅腫或有滲液，或腰側痛

要記住嘅三件事

1. 新膀胱係用腸造成並接駁尿道嘅，毋需外袋，可以正常排尿。
2. 需要練習：日夜定時排尿、做盆底運動，有時需要自我導尿。控制力會逐漸改善，初期漏尿係正常嘅。
3. 術前遵從禁食及腸道清潔指示並戒煙。保留尿管直至醫療團隊在 X 光確認後拔除，若排唔到尿或尿管唔滴尿，請即刻求醫。